Réalisé par Zacharie EKANG ENDERLIN et Samir APLOGAN
Etudiant en L3 Géographie à l'Université Bourgogne Europe

# Accès aux soins dans le Doubs : une équité territoriale fragile dépendante des structures relais

**Quelques chiffres clés**

**92,8 % : Patientèle couverte en urgence (<30min) actuellement.**

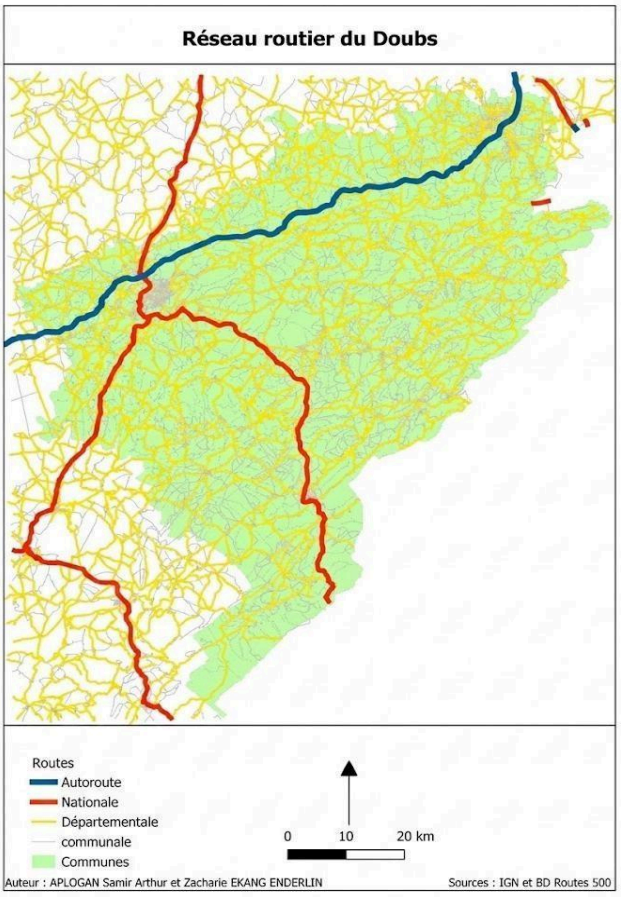
**49,7 % : Part de la population couverte si l'on ne conservait que les hôpitaux de Besançon et Montbéliard.**

**3 : Nombre de nouvelles MSP nécessaires pour atteindre 97% de couverture de proximité**.

**La concentration de l'offre de soins le long de la vallée du Doubs assure une couverture efficace à 93 % de la population, mais laisse subsister des zones de vulnérabilité en montagne. Si le maillage actuel gomme les contraintes du relief, cette performance repose sur un équilibre précaire que seule une optimisation ciblée des maisons de santé permettrait de consolider durablement.**

## Une dualité territoriale marquée

Le département du Doubs se caractérise par une forte dualité entre l'axe urbanisé de la vallée, emprunté par l'autoroute A36, et les territoires de montagne frontaliers. Dans un contexte de polarisation urbaine et de reprise démographique diffuse dans certains espaces ruraux, la question de l'équité d'accès aux soins devient centrale.
Cette étude mobilise les temps de parcours routiers et la localisation des équipements de santé pour apprécier la résilience de l'offre face aux risques de centralisation. Elle s'appuie sur la modélisation de deux scénarios : la robustesse de l'accès aux urgences et l'optimisation des soins de proximité.




**La lecture du réseau routier : la matérialisation de la fracture territoriale du Doubs.**

L'autoroute A36 (en bleu) constitue l'épine dorsale rapide de la vallée, connectant les pôles urbains majeurs. À l'inverse, la desserte du Haut-Doubs et de la zone frontalière repose sur un maillage de nationales et départementales (en rouge et jaune).

Si ce réseau secondaire est dense, il reste contraint par la topographie jurassienne, imposant une inertie forte aux déplacements.

C'est cette morphologie de réseau, plus que la distance kilométrique, qui conditionne les temps d'accès aux soins.

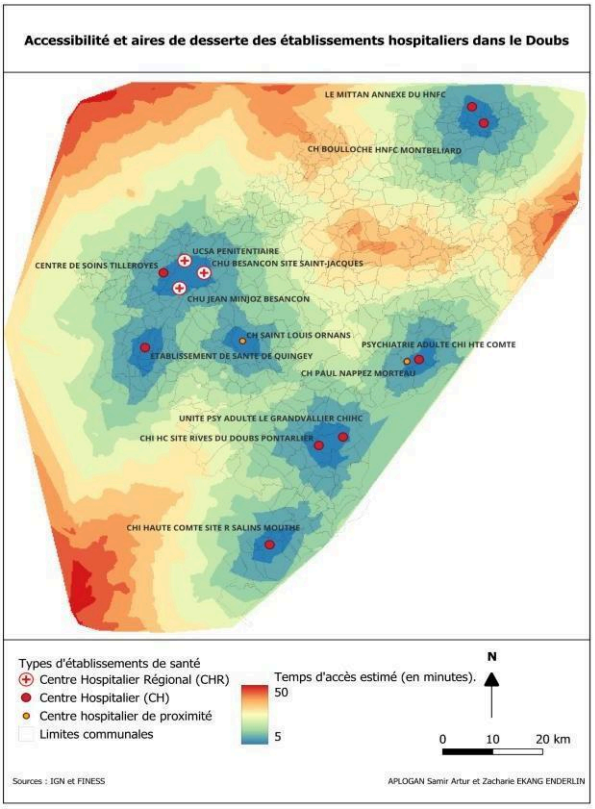


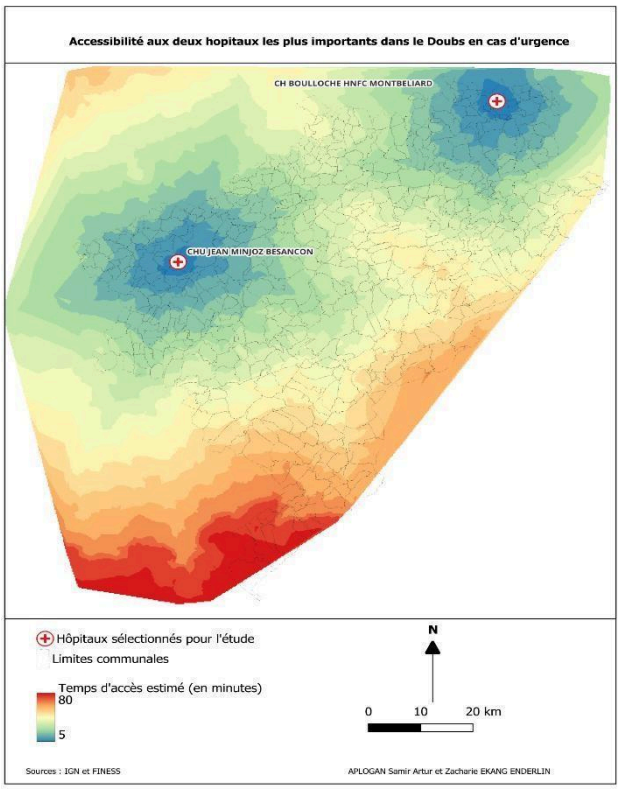

*Figure 2: une couverture structurée par le relief, où les hôpitaux relais (Pontarlier, Morteau) qui jouent un rôle pivot pour désenclaver les zones de montagne.*

Si le maillage hospitalier actuel permet de couvrir 92,8 % de la population en moins de 30 minutes, cette performance masque des fragilités structurelles liées au relief et à la dispersion de l'habitat.

**Le corridor urbain : une accessibilité résiliente** Les territoires situés le long de l'axe structurant de l'A36 (Besançon-Montbéliard) bénéficient d'une offre de soins dense et redondante. La concentration des infrastructures hospitalières et routières garantit des temps d'accès minimaux, insensibles aux restructurations. Par exemple, les bassins de vie de Besançon et Montbéliard concentrent la majorité de la population couverte en moins de 15 minutes.

## L'accessibilité aux urgences : une performance sous dépendance

*Figure 3 : Simulation de l'accessibilité aux urgences dans une configuration restreinte aux deux pôles majeurs*




**Les marges montagnardes : une couverture conditionnelle**

Les territoires du Haut-Doubs et de la zone frontalière disposent actuellement d'un bon accès aux urgences grâce aux hôpitaux de proximité. Cependant, ces zones sont en situation de vulnérabilité structurelle : leur couverture ne tient qu'à la présence d'établissements relais spécifiques comme le montre la figure 2. En restreignant l'offre aux seuls pôles de Besançon et Montbéliard, la carte change radicalement de physionomie : la continuité territoriale est rompue. Les vastes plages rouges au sud et à l'est matérialisent l'enclavement immédiat du Haut-Doubs (Pontarlier) et du Val de Morteau, où les temps d'accès dépassent désormais les 50 minutes. Ce scénario confirme que sans ses hôpitaux-relais, près de la moitié de la population du Doubs (49,7 %) se retrouverait exclue de la zone d'intervention rapide (< 30 min).

## De la vulnérabilité à l'optimisation locale

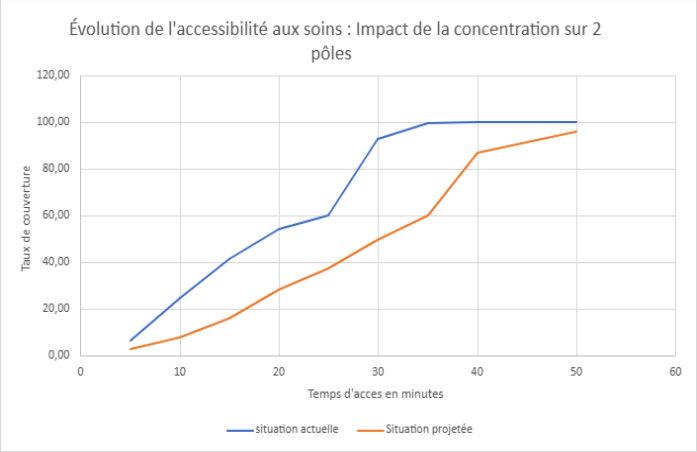


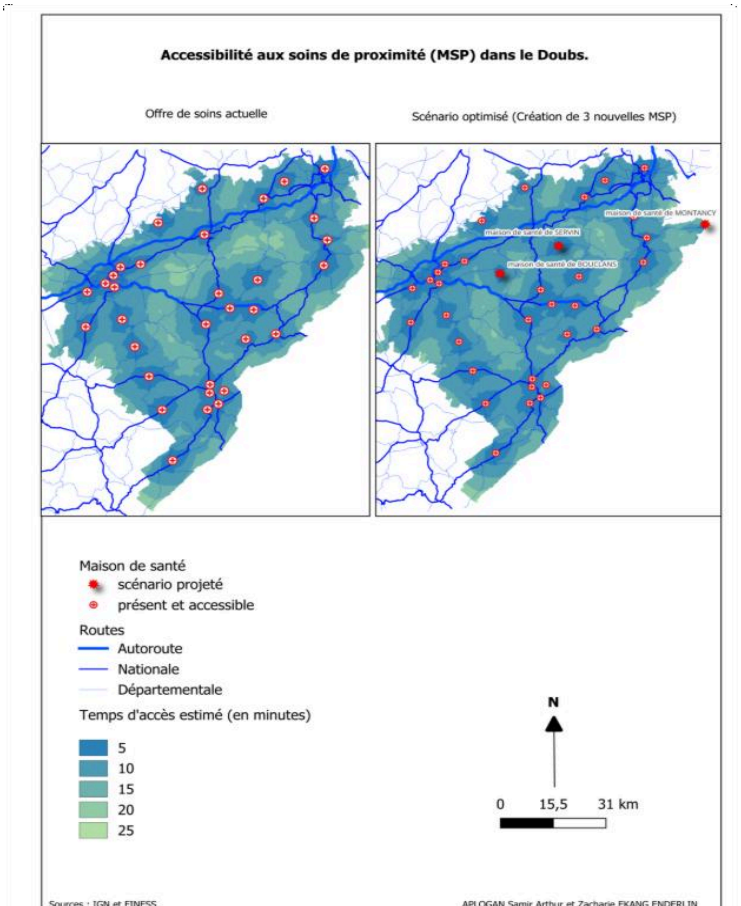

*Figure 4 : Taux de couverture et impact de la concentration sur 2 pôles*

Ce graphique ci-contre illustre la dépendance critique du territoire.

Alors que la situation actuelle (courbe bleue) atteint rapidement une couverture quasi-totale, le retrait de l'offre relais (courbe orange) entraînerait un effondrement du taux de couverture global (chute de 93 % à 50 %).

Dans ce scénario restreint, le cœur urbain maintiendrait à lui seul une couverture pour près de 50 % de la population, laissant l'autre moitié du département essentiellement rurale et montagneuse dans une situation de dégradation majeure de l'accès aux soins.

## Face à ce constat, et pour les soins du quotidien ne nécessitant pas de plateau technique lourd, l'enjeu se déplace vers le maillage de proximité.




Certains espaces ruraux, situés à l'écart des grands axes et des villes-relais, restent relativement mal desservis par l'offre actuelle, avec des temps d'accès supérieurs à 20 minutes. Pour ces territoires, l'hôpital est loin et le maillage des MSP est incomplet. Le scénario prospectif démontre l'efficacité d'une densification ciblée. L'ajout de seulement 3 MSP (Montancy, Servin, et Bouclans) permet de résorber les zones blanches visibles à l'Est et au Centre. Ce réajustement permettrait d'atteindre 97 % de couverture optimale (< 15 min). La localisation des trois nouvelles MSP (Montancy, Servin, Bouclans) ne relève pas du hasard mais d'une analyse croisée entre zones blanches et dynamiques de peuplement. Le choix repose sur deux logiques d'aménagement distinctes.

*Figure 5 : Scénario prospectif de renforcement de l'offre de soins de proximit*

## CONCLUSION

### Vers une complémentarité des échelles

L'analyse territoriale de l'offre de soins dans le Doubs révèle une couverture sanitaire globalement performante, mais structurellement dépendante de l'équilibre entre la vallée urbaine et les pôles relais de montagne. Si le maillage hospitalier actuel gomme efficacement les contraintes du relief, toute rationalisation excessive ferait basculer près de la moitié du département en situation de déficit d'urgence.

À l'échelle locale, la résorption des dernières inégalités d'accès passe désormais par un déploiement ciblé de Maisons de Santé Pluridisciplinaires. Ces constats plaident pour une stratégie d'aménagement hybride, garantissant le maintien des structures d'urgence intermédiaires tout en densifiant l'offre de premier recours dans les interstices ruraux les plus isolés.

**Sources, Définitions, Méthodologies**

L'étude mobilise trois ensembles de données géographiques et statistiques complémentaires : la population communale issue du recensement Insee 2021, localisée au niveau des chefs-lieux, la patientèle potentielle pour estimer la demande de soins, et la localisation des établissements de santé provenant du répertoire FINESS.

**Définitions des indicateurs**

Le temps d'accès correspond au temps de trajet théorique minimal en véhicule particulier entre le chef-lieu de la commune de résidence et l'équipement de santé le plus proche (hôpital ou MSP selon le scénario).
Le taux de couverture désigne la part de la population départementale résidant à l'intérieur d'une zone d'accessibilité donnée.

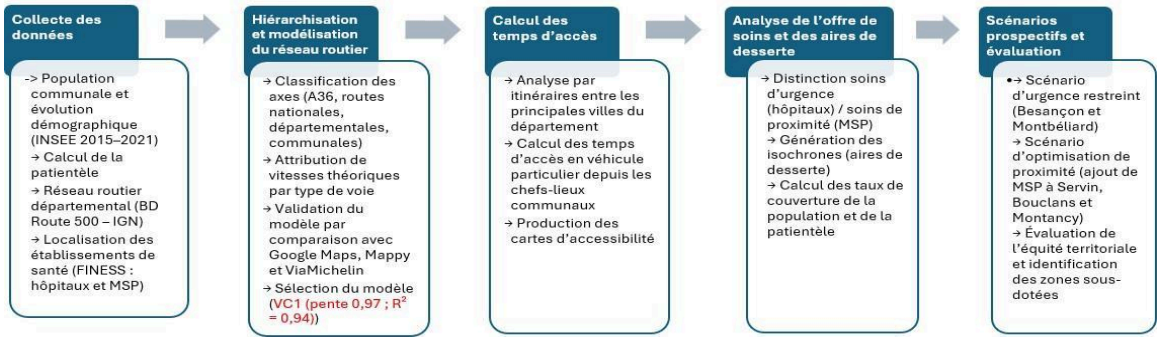
**Méthodologie**

L'analyse distingue l'offre de soins d'urgence (centres hospitaliers) et l'offre de soins de proximité (MSP). Les calculs d'itinéraires reposent sur la BD Route 500 de l'IGN, avec l'attribution de vitesses théoriques selon les catégories de voies. Des isochrones sont générées autour des équipements de santé et croisées avec la population afin de comparer trois scénarios : situation actuelle, offre d'urgence restreinte et offre de proximité optimisée.

**Limites de l'étude**

Les temps de parcours restent théoriques et ne prennent pas en compte le trafic réel ni les aléas météorologiques, notamment en zone de montagne. La localisation de la population au chef-lieu communal tend à lisser les disparités internes aux communes les plus étendues.

**La méthodologie de l'étude de l'accessibilité aux soins dans le Doubs**




## Bibliographies


*Insee. (2021). Accessibilité aux professionnels de santé – La France aux alentours de 2018. Insee Références*
*Insee. (2025). Dans le Grand Est, un quart des habitants des espaces ruraux vit dans un territoire sous-doté en médecins généralistes. Insee Analyses Grand Est, 86.*
*Commissariat général à l'égalité des territoires. (2023). Services – Indicateurs d'accessibilité aux services de santé. Observatoire des territoires…*